

УДК :618.19-006-089

Д.К. Алдынгуров, А.С. Аубакирова, Е.Ж. Каргабаев, С.Т. Олжаев
ГКП на ПХВ Алматинский региональный онкологический диспансер

Факторы местного рецидивирования после органосохранных операций у больных раком молочной железы

Аннотация. Главным прогностическим фактором рецидива РМЖ является локализация первичной опухоли. Доказано увеличение риска местного рецидивирования у женщин с опухолями внутренних/ центральных локализации по сравнению с наружными локализациями. Еще в 70-80 годах прошлого столетия доказано что после операционная лучевая терапия снижает риск местного рецидивирования до 5%, в то время как без лучевого воздействия этот риск составляет 30-40%. Радиологи утверждают что после операционная суммарная очаговая доза (СОД) на оставшуюся часть молочной железы составляет 50Гр. Снижение СОД приводит к повышению частоты рецидивирования до 10-15%, повышение дозы приводит к местным изменениям ткани молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы, местный рецидив, органосохранные операции.

Актуальность. Анализ прогностических факторов развития локального рецидива после органосохраняющего метода оперативного лечения рака молочной железы. В ранних стадиях частота рецидивирования составила 10,7% (3 пациенток из 28) с использованием модели Кокса, которая была приведена в таблице 1 сделан вывод о том, что молодой возраст женщины (моложе 45 лет) наличие обширного внутрипротокового компонента опухоли, центральная расположенность образования что часто влияет на возникновение местного рецидива. По данным исследования КазНИИОиР, среди онкопатологии женского населения Республики Казахстан за последние 5 лет рак молочной железы (РМЖ) с пятого места переместился на первое место (Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Ж., 2015) [1].

Риск развития рака молочной железы в возрасте старше 65 лет в 150 раз выше чем у лиц моложе 30 лет. Женщины с раком молочной железы чаще обращаются в специализированные лечебные учреждения, где ранняя выявляемость влияет на течение заболевания, выбор тактики лечения и выживаемость (Абдрахманова А.Ж., 1998) [2]. Органосохраняющее лечение РМЖ является одним из основных методов оперативного лечения с того времени как онкологи приняли биологическую системную модель Фишера. Основываясь на данных исследования по радикальному оперативному лечению РМЖ по Южному региону Алматинской области за последние 5 лет, из всего случаев проведенных операций на 1035 женщин, 482 случаев приходится на долю органосохраняющих радикальных операций. В связи с ростом выбора радикального органосохраняющего метода лечения ожидается увеличение числа женщин с местным рецидивом в последующем, так как по данным иссле-

дования НИИ клинической онкологии РОНЦ им Н.Н. Блохина [3]. Частота возникновения рецидивов в сохраненной железе колеблется от 2 до 10% в течении 5 лет и от 5 до 15% в течении 10 лет.

В медицинской литературе широко обсуждается прогностические факторы, влияющие на возникновение рецидивной опухоли. Это молодой возраст пациентки (35-40) в момент диагностирования первичной опухоли. Размер первичной опухоли один из значимых факторов возникновения местного рецидива РМЖ после органосохраняющих лечения (ОСЛ). По данным авторов, у пациенток с опухолью диаметром-1 см риск развития местного рецидива составляет 10% за 10 лет и 12% за 20 лет. При диаметрах-1-2 см риск составляет 25%, при диаметрах-2-4 см риск составляет 33%. Также широко обсуждается влияние на частоту развития местных рецидивов наличие опухолевых клеток по линии резекции удаляемого препарата. Выявлено, что у больных с наличием по линии резекции опухолевых клеток риск локального рецидивирования составляет 28,5%, а в отсутствии клеток по линии резекции-6%.

Особое значение в возникновении рецидива РМЖ играет преобладание внутрипротокового компонента опухоли. В опухолях с внутрипротоковым компонентом (extensive intraductal component, EIC) высоко вероятны остаточные очаги в сохранившейся ткани молочной железы, которые в частности являются инвазивными и располагаются на большом расстоянии от первичного опухолевого узла, чем EIC негативные опухоли. Доказано что мультицентричность очагов опухолевого роста наблюдается в 80% случаев преобладания внутрипротокового компонента в опухоли, в 50% -при дольковом и инвазивном раке и в 20% – при потоковом инвазивном раке [4].

Материал и методы исследования. На базе отделения химиотерапии АРОД проведено исследовательская работа, где наблюдались 28 пациенток получившие ОСЛ.

Средний возраст пациенток во время лечения первичной опухоли составила 50 лет. Медиана периода наблюдения 3 года. Местные рецидивы в оперированной молочной железе диагностированы у 3 человек из 28 (10,7%).

Данные описательной статистики, характеризующие клинический материал представлены в таблице 1.

Таблица 1 Относительная статистика исследуемых прогностических факторов местного рецидивирования

Фактор	группы	Число больных в группе	Число местных рецидивов	Отношения шансов	95% доверительный интервал	Уровень статистической значимости
возраст	Моложе 45	21	3	2,1	1,5	Более 0,001
	45 и старше	7	-	-	-	-
pT	pT1	16	2	0,025	0,1-0,01	0,56
	pT2	5	1	0,002	0,0001	0,002
Локализация опухоли	наружная	8	1	1,84	0,95	0,70
	внутренняя	4	2	2,0	2,0-2,1	1,95
	центр	2	-	-	-	-
	Гр-ца верхних квадрантов	4	-	-	-	-
	Гр-ца нижних квадрантов	3	-	-	-	-
Сосудистая инвазия	Нет	1	1	-	-	-
	Есть	6	2	1,65-1,8	1,0-1,32	1,0
Метастазы в регионарных лимфатических узлах	Нет					
	Есть	6	-	-	-	-
СОД, Гр	Менее 48	5	2,0-2,56	2,0	1,95-2,0	2,0
	48 и более	14	-	-	-	-
Гистологическая структура опухоли	Индольковый рак	2	1,0-1,65	1,0	1,05	1,65-2,0
	Инф-протоковый рак	8	0,5-0,95	0,5-0,1	1,0	1,0
	Инф-протоковый рак с внутрипротоковым компонентом	11	1,5-1,59	1,0-0,58	0,95	0,8
	Смешанный рак	-	-	-	-	-
	Инфильтративный рак	7	0,4-0,8	0,5-0,1	1,0	0,95
	другие	-	-	-	-	-

Характеристика первичного лечения. Хирургическое лечение проводилось в объеме Радикальной резекции молочной железы из одного или двух разрезов в зависимости от локализаций первичной опухоли. Послеоперационная дистанционная лучевая терапия на молочную железу проведена 69,3% больных (19 из 21). Облучение проводили в режиме стационарного фракционирования СОД 44-48 Гр.

Пациенткам с внутренней локализацией опухоли проводилось облучение зоны парастеральных лимфатических узлов используя СОД от 46-80Гр.

Гормонотерапию тамоксифеном от 2 до 5 лет проводили у пациенток с положительным гормональным статусом опухоли.

У пациенток с сохраненной менструальной функцией предварительно выключали функцию яичников медикаментозно.

Химиотерапию проводили по схеме CMF -в 15,5% случаев, FAC-в 15,7%

Результаты и обсуждение. Результаты регрессионного анализа показаны в таблице 1.

В таблице для каждого фактора оценены отношения шансов местного рецидивирования между группами с 95% доверительным интервалом и уровнем статистической значимости.

Результаты многофакторного анализа показывают, что статистически значимыми прогностическими факторами, влияющими на возникновение местных рецидивов, являются следующие:

- Возраст женщины с увеличением шансов рецидивирования в группе моложе 45 лет по отношению к группе 45 лет и старше;
- локализация опухоли с увеличением шансов в группах с центральной локализацией и границей верхних квадрантов по отношению к наружной локализации;
- гистологическая структура опухоли с увеличением шансов в группе инфильтративно-протокового рака с внутрипротоковым компонентом по отношению к инфильтративно-дольковому и инфильтративно-протоковому раку.

Влияние других прогностических факторов на возникновение местных рецидивов по данным данного многофакторного анализа статистически незначимо. Надо отметить, что относительно СОД, подведенной к молочной железе, отмечается тенденция к повышению шансов рецидивирования в группе пациенток с СОД менее 48Гр по отношению к группе пациенток с СОД 48Гр и более [5].

Заключение. На основании нашего анализа, несмотря на относительно малое число пациенток с местными рецидивами, что может нивелировать статистическую значимость влияния некоторых прогностических факторов, где можно сделать вывод, что молодой возраст женщины, наличие внутрипротокового компонента, центральная локализация опухоли является статистически значимыми прогностическими факторами возникновения местного рецидива после органосохраняющих операции.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Байпеисов Д.М., Сейтказина Г.Д., Жылкайдарова А.Ж. Организация деятельности специализированных консультативно-диагностических отделений онкологических диспансеров //Онкология и радиология Казахстана.- 2015.-№ 3 (20).-С. 41-42.
2. Абдрахманова А.Ж. Интратуморальная радиосенсибилизация в комплексной терапии местнораспространенного рака молочной железы. Казах. НИИ онкологии и радиологии. - Алматы, 1998. -С.21-22
3. Уйманов В. А., Нечушкин М. И., Гладилина И.А. Местные рецидивы после операции на молочной железе.- М.: РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, 2009.
4. Высоцкая И.В. Лечение рака молочной железы 0–II стадий: Автореф... докт. мед. наук. – М., 1999. - С. 31-35.
5. Fisher B., Brown A., Mamouni E. et al. Effect of preoperative therapy for primary breast cancer (B C) on loco-regional disease, disease-free survival (DFS) and Survival (S): Results from NSABP B-18. Proc Annual Meeting Soc // Oncol. – 1997: Vol. 16: P.127 (abstr 449).

ТҰЖЫРЫМ

Д.К. Алдынгуров, А.С. Аубакирова, Е.Ж. Каргабаев, С.Т. Олжаев
«Алматы аймақтық онкологиялық диспансері» ШЖҚ МҚК

Сүт безі қатерлі ісігімен ауыратын науқастардың мүшелерін сақтау операциядан кейін жергілікті қайталану факторлары

Сүт безі қатерлі ісігі рецидивінің негізгі болжамдық факторы болып біріншілік ісіктің орналасуы табылады. Әйелдерде ісіктердің жергілікті рецидивтену қаупі ішкі/орталық орналасқандары сыртқы орналасқандармен салыстырғанда жоғары екендігі дәлелденген. Өткен жүзжылдықтың 70-80 жылдарында-ақ отадан кейінгі сәулелі ем жергілікті рецидив қаупін 5%-ға дейін төмендететіні, сәулелік емсіз бұл қауіп 30-40%-ға құрайтыны дәлелденген. Радиологтардың бекітуі бойынша сүт безінің қалған бөлігіне операциядан кейінгі жалпы ошақтық доза (ЖОД) 50Гр құрайды. ЖОД төмендеуі рецидивтену жиілігінің 10-15%-ға дейін жоғарылауына әкелсе, дозаны көтеру сүт безі тіндерінің жергілікті өзгерістеріне әкеледі.

Түйінді сөздер: сүт безі обыры, жергілікті рецидив, ағза сақтау отасы.

SUMMARY

D.K. Aldyngurov, A.S. Aubakirova, E.Zh. Kargabayev, S.T. Olzhayev
Almaty Regional Oncology Center

The factors of local recurrence after breast conserving surgery in patients with breast cancer

The main predictor of breast cancer recurrence is the location of the primary tumor. It is proven to increase the risk of local recurrence in women with tumors of the inner / central localization in comparison with external localizations. In the 70-80s of the last century it proved that after operating radiotherapy reduces the risk of local recurrence to 5%, while without the radiation exposure to the risk of 30-40%. Radiologists say that after operating the total focal dose for the remainder of the breast is 50G. Reduction of total focal dose increases the frequency of recurrence to 10-15% increase in dose leads to local changes in breast tissue.

Keywords: Breast cancer, local recurrence, ablative surgery.